OPERATING DASHBOARD — AI Ghi chép Hội thoại Khám bệnh

Loại mô hình: B2B · Cập nhật: 09/10/2026 · Nguyen Anh Dung – 2A202602554

Sản phẩm: AI ghi nhận hội thoại khám bệnh, tạo bản nháp hồ sơ có cấu trúc, để bác sĩ duyệt trước khi import vào EHR. Bản chưa được bác sĩ duyệt không được ghi vào hồ sơ chính thức.

NORTH STAR

Time-to-first-value (TTFV): chưa có dữ liệu — mục tiêu <30 ngày/khách pilot

Số ngày từ lúc bắt đầu pilot đến khi có note khám đầu tiên được bác sĩ duyệt và import thành công vào EHR.

Đèn báo sớm — Leading

Đèn	Hiện	Xanh / Vàng / Đỏ	Nguồn	Báo trước cho
TTFV	Chưa đo	Xanh <30 ngày · Vàng 30–60 · Đỏ >60	[TB]	POC → paid, usage depth
Tỷ lệ note được bác sĩ duyệt để import	Chưa đo	Xanh ≥85% · Vàng 70%–<85% · Đỏ <70%	[TB]	Usage depth, POC → paid

Đèn vận hành — Operating

Đèn	Hiện	Xanh / Vàng / Đỏ	Nguồn	Báo trước cho
Usage depth trong tài khoản	Chưa đo	Xanh ≥60% · Vàng 30%–<60% · Đỏ <30%	[TB]	Gia hạn, mở rộng hợp đồng
POC → paid	Chưa có POC	Xanh ≥50% · Vàng 35%–<50% · Đỏ <35%	[TB]	Doanh thu, NRR
Chi phí triển khai ÷ ACV	Chưa đo	Xanh <15% · Vàng 15–30% · Đỏ >30%	[MH]	Gross Margin, khả năng scale
AI cost per validated encounter	Chưa đo	Xanh ≤5.400đ · Vàng 5.401–9.000đ · Đỏ >9.000đ	[MH]	Gross Margin

Đèn kết quả — Lagging

Đèn	Hiện	Xanh / Vàng / Đỏ	Nguồn
Gross Margin	Chưa có doanh thu	Xanh ≥55% · Vàng 45%–<55% · Đỏ <45%	[TB]
CAC payback	Chưa đo	Xanh <12 tháng · Vàng 12–18 · Đỏ >18	[TB]

5 luật quyết định ([DỪNG] = luật dừng)

1. NẾU TTFV >60 ngày TRÊN 3 khách pilot gần nhất VÀ mỗi khách đã có ít nhất 10 ngày sử dụng thực tế THÌ cắt pilot xuống một chuyên khoa và một workflow import SOAP note KHÔNG THÌ không tuyển thêm sales để ký pilot rộng hơn. [DỪNG]

2. NẾU tỷ lệ note được bác sĩ duyệt để import <70% TRONG 2 tuần liên tiếp VÀ có ít nhất 100 note đã được bác sĩ xem THÌ đóng băng tính năng mới, phân tích 20 note bị từ chối và sửa nhóm lỗi đứng đầu trong 2 tuần KHÔNG THÌ không triển khai rộng. [DỪNG]

3. NẾU chi phí triển khai >30% ACV TRÊN 3 khách liên tiếp THÌ chuẩn hóa cấu hình, connector EHR và onboarding, hoặc tăng giá triển khai KHÔNG THÌ không nhận khách mới với cùng phạm vi tùy biến.

4. NẾU usage depth <30% SAU 60 ngày go-live VÀ tài khoản có ít nhất 10 bác sĩ được cấp quyền THÌ đào tạo lại theo một workflow và đặt mục tiêu 60% trong 30 ngày KHÔNG THÌ không bán thêm module.

5. NẾU AI cost per validated encounter >9.000đ TRONG 2 kỳ tính phí liên tiếp VÀ gross margin dự phóng <45% THÌ chuyển workflow nặng sang model/routing tiết kiệm hơn và giới hạn lượt dùng chưa tạo giá trị KHÔNG THÌ không tăng lượt khám miễn phí để theo đuổi tăng trưởng danh nghĩa. [DỪNG]

Cổng gác 90 ngày

Ngày	Metric (1)	Ngưỡng qua cổng	Bằng chứng	Nếu trượt
30 (08/11/2026)	Số encounter được đánh giá lỗi	≥100 encounter được bác sĩ gán loại lỗi và xác định 3 nhóm lỗi lớn nhất	eval.csv, báo cáo lỗi ẩn danh	GO nếu đạt; FIX 30 ngày bổ sung mẫu
60 (08/12/2026)	Số khách đạt TTFV <30 ngày	≥2 khách; khách chưa đạt vẫn nằm trong mẫu	pilot-start log, approval log, EHR receipt	GO nếu đạt; FIX onboarding một lần
90 (07/01/2027)	POC → paid	≥35%, mẫu ≥3 pilot kết thúc	danh sách pilot, hợp đồng trả phí	GO nếu đạt; PIVOT nếu giả định sai; KILL nếu đã FIX cùng vấn đề mà không cải thiện

KILL CRITERIA: Ngày 07/01/2027, nếu có ≥3 pilot kết thúc và đã FIX chuyển đổi một lần nhưng vẫn 0 hợp đồng trả phí, dừng hướng triển khai hiện tại. Thiếu mẫu: PIVOT kênh/phân khúc, không tuyên bố đã qua cổng.

CHƯA ĐO ĐƯỢC: TTFV, tỷ lệ note được duyệt, usage depth, chi phí triển khai/ACV, AI cost/encounter, Gross Margin và CAC payback. Cần event tracking theo từng khách, log EHR import, audit log bác sĩ duyệt/từ chối, timesheet triển khai, hóa đơn speech-to-text/LLM/hạ tầng, CRM và dữ liệu kế toán. Dự kiến có baseline đầu tiên sau 2 tuần pilot: 23/10/2026.

NGUỒN/LÝ DO: [TB] là ngưỡng nội bộ dự kiến, chưa đo; [MH] là mô hình minh họa chưa xác nhận. Lý do từng đèn và phép tính ở worksheet. Chưa dùng benchmark đã xác minh. Baseline sau 2 tuần pilot thật; ngày 23/10 chỉ là mốc dự kiến thiết lập tracking.

Phụ lục [MH] — phép tính

[MH] 1 — Chi phí triển khai ÷ ACV

Giả định ACV của một phòng khám/bệnh viện nhỏ = 240.000.000đ/năm

Mục tiêu chi phí triển khai tối đa = 15% ACV

Ngưỡng xanh = 240.000.000 × 15% = 36.000.000đ/khách

Ngưỡng đỏ theo luật B2B = 240.000.000 × 30% = 72.000.000đ/khách

Kết quả → Xanh <36.000.000đ · Vàng 36.000.000–72.000.000đ · Đỏ >72.000.000đ

[MH] 2 — AI cost per validated encounter

Giả định giá bán = 20.000.000đ/tháng

Giả định 1.000 lượt khám được validate/tháng

Doanh thu trên một lượt khám = 20.000.000 ÷ 1.000 = 20.000đ

Để dành tối thiểu 55% gross margin, tổng COGS tối đa = 45% × 20.000đ = 9.000đ/lượt

Phân bổ tối đa 60% COGS cho AI (speech-to-text + LLM + lưu trữ)

= 9.000 × 60% = 5.400đ/lượt.

Phần còn lại dành cho hạ tầng và hỗ trợ biến đổi:

Xanh ≤5.400đ · Vàng 5.401–9.000đ · Đỏ >9.000đ/lượt

Đây là ngưỡng mô hình tạm thời, phải thay bằng Cost/Job đo từ hóa đơn và log token thật.

Các đầu vào 20 triệu/tháng, 1.000 lượt/tháng và ACV 240 triệu/năm là giả định minh họa, chưa có mô hình tài chính thực tế xác nhận. Ngưỡng chi phí triển khai 15%/30% là ngân sách giả định; phép nhân không tự chứng minh khả năng sinh lời.